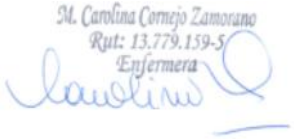


	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 11

Guía de Administración de Medicamentos por Vía Intramuscular

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando

Leyton A. Peralillo

Elaborado por: EU Catherine Soto F.	Revisado por: EU María Carolina Cornejo Z	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Enfermera CESFAM Peralillo	Cargo: Enfermera coordinadora SUR (s)	Cargo: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 17 Octubre de 2023	Fecha: 19 Octubre de 2023	Fecha: 20 Octubre 2023
Firma:  Catherine Soto Fariñas Rut: 17.775.285-1 Enfermera	Firma:  M. Carolina Cornejo Zamorano Rut: 13.779.159-5 Enfermera	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 2 de 11

I. INTRODUCCION.

La inyección administrada por vía Intramuscular (IM) deposita el medicamento en el tejido muscular profundo.

El tejido intramuscular es más vascularizado y tiene más inervación que el tejido celular subcutáneo, por estas razones la absorción es más rápida y hay mayor riesgo de lesionar nervios y vasos. Cualquier factor que interfiera en el flujo sanguíneo tisular local afecta a la velocidad y magnitud de la absorción del fármaco por ese motivo se deben utilizar músculos sanos para las inyecciones.

El músculo es menos sensible a los fármacos irritantes y viscosos. Aquellos que están adelgazados absorben muy poco la medicación, por lo que deberían evitarse cuando sea posible.

Los factores que determinan una buena absorción del medicamento son: el estado cardiovascular y de líquidos del paciente, el estado del tejido intramuscular y de la habilidad para administrar la inyección.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General

Estandarizar el procedimiento de administración de medicamentos vía intramuscular y manejo del acceso intramuscular, considerando la prevención de IAAS y eventos adversos asociados.

b. Objetivos específicos

- Unificar criterios en el equipo de salud para la administración de medicamentos por vía intramuscular.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 11

- Minimizar las complicaciones relacionadas con la administración de medicamentos por vía intramuscular, mediante un correcto manejo.

III. ALCANCE

Aplica a todos los funcionarios y unidades en que se realice administración de medicamentos vía intramuscular.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- Médico: Indicación de la administración de medicamentos vía intramuscular.
- Enfermera: Administración de medicamentos intramuscular con indicación médica y supervisión del procedimiento.
- Técnicos en Enfermería: Administración de medicamentos intramuscular con indicación médica.

V. DEFINICIONES

Administración de medicamentos: Es el procedimiento mediante el cual un fármaco es proporcionado por el personal de salud calificado al paciente por distintas vías de administración, según indicación médica escrita y que debe ser debidamente informado y registrado.

Vía intramuscular (IM): Consiste en la introducción de sustancias medicamentosas en el tejido muscular, usada principalmente en aquellos casos en que se quiere una mayor rapidez, pero no puede ser administrado por la vía venosa, como por ejemplo, las sustancias liposolubles. La velocidad de absorción dependerá de factores como la masa muscular del sitio de inyección y la irrigación sanguínea. La absorción del medicamento puede sufrir retardo en

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 11

el tiempo dependiendo de sus características físico - químicas, como es en niños prematuros, desnutridos y adultos obesos. Si el principio activo va disuelto en medio oleoso, la absorción es lenta y mantenida.

Infección del sitio de inserción: Eritema, induración, mayor sensibilidad y/o exudado en un área de 2 centímetros en torno al punto de exteriorización. Puede asociarse o no con otros síntomas y signos de infección, tales como fiebre o pus en el sitio de la salida, con o sin infección del torrente sanguíneo concomitante.

Zona dorsoglútea: Se localiza en el cuadrante superior externo de la nalga, así es como se evita lesionar el nervio ciático. Es el lugar que más medicamento admite: hasta 5 ml. (en un adulto). El paciente debe estar en decúbito prono. Debe de evitarse su uso en los menores de tres años.

Zona deltoidea: Está ubicada en la cara externa del deltoides, a 3 traveses de dedo por debajo del hombro. Admite hasta 2 ml de volumen. El paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones: sedestación, decúbito supino, decúbito lateral o bipedestación.

Zona ventroglútea: Es una de las más seguras, ya que no tiene cerca ningún punto conflictivo. Con el enfermo en decúbito lateral o en decúbito supino, colocaremos nuestra mano en la base del trocánter mayor del fémur del lado elegido. A continuación abriremos los dedos de la mano y puncionaremos en el espacio que quede entre los dedos índice y medio. Admite hasta 5 ml. de volumen.

Cara externa del muslo: Admite hasta 5 ml de volumen. Con el paciente en decúbito supino o en sedestación, delimitaremos una línea imaginaria que vaya, por la cara externa del muslo elegido, desde el trocánter mayor hasta la rótula. La zona óptima de inyección está localizada en ésta línea, 5 cm. por arriba y 5

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 5 de 11

cm. por debajo de su punto medio. Es la zona de elección para los niños menores de tres años.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA INTRAMUSCULAR

Equipo e insumos:

- Jeringas de diferentes calibres (3cc o 5cc)
- Agujas
- Tórulas de algodón secas
- Antiséptico Alcohol al 70% (tórulas con alcohol o sachet de alcohol).
- Suero fisiológico, agua para inyectables.
- Riñón para transporte de insumos
- Pinza Kelly
- Contenedor para material cortopunzante
- Parche curita o algodón seco más tela adhesiva.

Procedimiento:

1. Realice lavado clínico de manos.
2. Prepare el o los medicamentos en el área limpia
3. Verifique el nombre del fármaco
4. Abra el envase de la jeringa y colóquela en el riñón estéril, si el envase del fármaco es ampolla: Límpiela con tórula con antiséptico y quiebre.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 11

5. Introduzca la aguja en el líquido y aspire el contenido con la cantidad indicada.
6. Antes de eliminar la ampolla vuelva a leer el nombre de fármaco.
7. Si el envase es frasco con tapa de goma y contenido líquido: pincele la superficie de la tapa de goma utilizando tórula con antiséptico.
8. Aspire en la jeringa cantidad de solución que debe inyectar.
9. Puncione la tapa.
10. Invierta el frasco aspire la cantidad indicada y retire la aguja.
11. Invierta la jeringa y expulse las burbujas.
12. Si el envase es de frasco con tapa de goma y contenido liofilizado (polvo):
Pincele la superficie de la tapa de goma usando tórula antiséptico.
13. Aspire el diluyente con la jeringa en la cantidad exacta indicada y pinche la tapa de goma para introducirlo al frasco.
14. Lleve el riñón al lugar donde se encuentra el usuario con todos los insumos necesarios.
15. Identifique al paciente.
16. Acomode e informe al paciente procedimiento a realizar.
17. En caso de pacientes pediátricos explicar el procedimiento a acompañantes y la necesidad de inmovilización si es necesario.
18. Inspeccione sitio a puncionar
19. Seleccione la zona para la inyección, valorando condiciones de la piel, el tamaño y la integridad muscular. En la piel descarte las áreas de sensibilidad, induración, existencia de hematomas o infección local. Los músculos relajados deben estar blandos y cuando se tensan deben ser firmes. Si las inyecciones van a ser frecuentes, alterne los puntos.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 11

20. Cambie la aguja. Acomode al paciente con la zona a puncionar descubierta. La posición decúbito prono disminuye el estiramiento muscular y disminuye las molestias.
21. Limpie la zona con solución antiséptica (Alcohol 70%) y espere evaporación (30 segundos).
22. Puncione la piel, la aguja se debe de introducir formando un ángulo de 90° con un movimiento firme y seguro, en un solo acto.
23. Antes de introducir el medicamento siempre se debe aspirar para ver si hemos conectado con un vaso. En caso afirmativo, debemos extraer la aguja y puncionar nuevamente en otro lugar.
24. El medicamento se debe inyectar lentamente ya que, aparte de ser menos doloroso, iremos dando tiempo a que se vaya distribuyendo por el músculo. Durante todo el procedimiento iremos observando cómo va reaccionando el paciente y le preguntaremos si tiene dolor, si se encuentra mareado, etc.
25. Una vez administrado todo el medicamento, esperaremos unos diez segundos antes de retirar la aguja, pues así evitaremos cualquier pérdida de medicación.
26. Colocaremos la tórula de algodón seca justo sobre el punto de la inyección y retiraremos la aguja con suavidad y rapidez.
27. Posteriormente haremos una suave presión mientras friccionamos ligeramente la zona para evitar que el medicamento se acumule y así favorecer su absorción.
28. Colocamos un parche curita o algodón seco con tela adhesiva en la zona de punción.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 8 de 11

29. Retire aguja con pinza Kelly y elimine en material cortopunzante.
30. Lave sus manos una vez finalizado el procedimiento.
31. Registre el procedimiento en DAU (Dato de Atención de Urgencias) o ficha clínica según corresponda.

VII. EVALUACIÓN

Indicador N°1: Porcentaje de cumplimiento de pauta de supervisión de administración de medicamentos vía intramuscular.

Tipo de indicador: Proceso

Desarrollo del indicador:

(N° de administración de medicamentos vía intramuscular con cumplimiento Aprobado de pauta de cotejo/ N° total de administración de medicamentos vía intramuscular con pauta de cotejo aplicada)x 100

Observación: Se considera cumplimiento aprobado en el caso de lograr la ejecución correcta del 90% y más de los pasos a seguir.

Periodo de evaluación: Semestral

Muestreo: Según conveniencia y oportunidad.

Umbral de cumplimiento: 80%

Método de verificación: Pauta de supervisión de administración de medicamentos vía intramuscular (Anexo 1). Se podrá realizar en hoja impresa o en sistema de tabla Excel.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 9 de 11

VIII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección CESFAM Peralillo.
- Servicio de Urgencia Rural (SUR)
- Postas Rurales: Población, Los Cardos, Calleuque y EMR Rinconada de Molineros.
- Unidad de Calidad y seguridad de Usuario, CESFAM Peralillo.
- Box de enfermería.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Protocolo y Manual de Procedimientos Clínicos Asistenciales CESFAM Mariquina, (2016).
- Guía Administración de Medicamentos Vía Parenteral Intramuscular, Subcutánea E Intradérmica, Duoc Uc, Escuela De Salud. (2016).

X. AUTORES

EU Catherine Soto Farías.

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 10 de 11

XI. ANEXOS

Anexo 1. Pauta de supervisión administración de medicamentos intramuscular

UNIDAD		
FUNCIONARIO		
FECHA		
PERSONA QUE EVALÚA		
Completar con Si/No		
1.- Verifica la indicación médica.		
2.- Selecciona todos los materiales indispensables para el procedimiento: jeringa, medicamento correcto, aguja para extraer medicamento, antiséptico (alcohol), tórula, riñón, pinza kelly, cortopunzante, basurero.		
3.- Lavado clínico de manos		
4.- Limpia la ampolla o frasco ampolla del fármaco con tórula con alcohol.		
5.- Prepara medicamento manteniendo asepsia.		
6.- Extrae correctamente la dosis indicada para administrar.		
7.- Elimina aguja que preparó medicamento y coloca nueva aguja con la que va a puncionar.		
8.- Explica el procedimiento al paciente.		
9.- Desinfecta el sitio de punción con un sachet o tórula con alcohol al 70%.		
10.- Tome firmemente, con la mano no dominante la zona preparada, traccionándola para estirar la piel.		
11.- Con la mano dominante toma la jeringa, retira la cápsula		

	GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR	Código:	GCL 1.3
		Fecha:	Octubre de 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 11 de 11

de la aguja y punciona en ángulo de 90° con un movimiento rápido y seguro.		
12.- Aspira suavemente para asegurarse de no haber caído en un vaso sanguíneo e inyecta el medicamento lentamente.		
13.- Retira la aguja en el mismo ángulo que la insertó		
14.- Aplica presión suave con tórula seca luego de retirar aguja.		
15.- Elimina aguja en caja de cortopunzante, elimina material en basurero.		
16.- Realiza lavado clínico de manos		
17.- Realiza registro de procedimiento en ficha clínica o DAU.		